

URGENCIAS OTOLÓGICAS: PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO

K. N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

I. TRAUMATISMOS

Otohematoma

Introducción

Acúmulo de sangre en el espacio subpericóndrico del pabellón auricular, secundario a un traumatismo.

Diagnóstico

Inspección: Deformidad de pabellón auricular con pérdida de relieves.

Tratamiento En Urgencias

Drenaje de contenido bajo anestesia local previa asepsia:

- Punción y aspiración en pequeñas colecciones
- Incisión en el punto de mayor declive, extracción de coágulos y drenaje de Penrose con un punto de sutura no reabsorbible que se debe mantener durante 48 horas.

Vendaje compresivo que se adapte a la superficie del pabellón.

Profilaxis antibiótica antipseudomona: Ciprofloxacino 500mg VO cada 12 horas 7 días y revisión con especialista.



Otohematoma derecho

Heridas inciso-contusas

Introducción

Las heridas de pabellón auricular suelen ser secundarias a una acción mecánica. Pueden afectar piel, partes blandas, espesor de cartílago, con pérdida de sustancia, hasta arrancamiento de la oreja.

Diagnóstico

Inspección de toda la oreja, búsqueda de exposición de cartílago o hematomas asociados por traumatismos.

Tratamiento En Urgencias

- Lavado y desinfección
- Sutura de la herida con anestesia local. En caso de exposición o compromiso de cartílago, realizar la sutura solo de piel sin coger cartílago.
- Tratamiento antibiótico: Ciprofloxacino 500mg VO cada 12h 7 días (Principalmente en casos de afectación de cartílago).
- Si pérdida de sustancia o arrancamiento: Avisar a especialista

II. INFECCIONES

Pericondritis del pabellón

Introducción

Infección del pericondrio, secundario a traumatismos, heridas, quemaduras, otohematoma infectado, piercing. Agente etiológico: *Pseudomona aeruginosa*.

Diagnóstico

Oreja afectada eritematosa con inflamación de pabellón auricular, fiebre, calor y dolor local, pueden presentar absceso subpericóndricos y necrosis cartilaginosa.

Tratamiento En Urgencias

Antibioticoterapia antipseudomona: Ciprofloxacino. La vía de administración dependerá del grado de afectación y estado general del paciente. Solicitar valoración por especialista. ORL



Pericondritis

Herpes zoster ótico o Síndrome de Ramsay-Hunt

Introducción

Afectación del VII PC por el virus de la varicela zoster; por ello afecta la piel correspondiente al territorio sensitivo de n. facial (área de Ramsay-Hunt).

Diagnóstico

Dolor intenso tipo quemazón en oído y erupción eritematovesicular en piel de concha (vesículas propias del herpes), conducto auditivo externo, cara externa de membrana timpánica, mucosa de paladar. Si se asocia parálisis hemifacial ipsilateral al oído afectado, vértigo periférico e hipoacusia neurosensorial hablamos del síndrome de Ramsay-Hunt y es producto de la afectación añadida del VIII para craneal que progresa hasta el ganglio geniculado. Nos plantearemos en urgencias según la clínica que presente el paciente pruebas complementarias como:

- Analítica sanguínea: hemograma, coagulación básica, bioquímica con PCR
- TC Craneal.

Tratamiento

- Aciclovir 800mg cada 4 horas 7 días o Valaciclovir 1gr cada 8 horas 7 días.
- Corticoides orales: controvertido, siempre que se exista parálisis facial que puede ocurrir en el 50% de los casos.

Alerta

- Si asocia síntomas vestibulococleares (Hipoacusia/vértigo) requiere valoración por especialista. ORL



Herpes Zoster Ótico

Erisipela

Introducción

Lesiones en placa bien delimitadas, bordes sobre elevados, brillantes, induradas y dolorosas, pueden existir formas ampollosas. Suelen presentar edema, calor, hiperemia, fiebre, tiritonas (temblores), malestar general y adenopatías satélites. La etiología es:

Más frecuente: Estreptococo β -hemolíticos del grupo A.

Menos frecuente: Estreptococos del grupo G y C y Staphylococcus aureus (incluido el S. aureus meticilino resistente [MRSA]), Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, S. warneri, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, y especies de Moraxella.

Diagnóstico

Se basa en la clínica y el examen físico que presente.

Localización: casi siempre en cara y extremidades inferiores (Piernas). El MRSA es más frecuente en erisipelas de localización facial.

Erisipela localizada en cara se debe de realizar diagnóstico diferencial con herpes zóster, el angioedema y la dermatitis de contacto.

Si afecta al pabellón auricular hay que diferenciarlo de la pericondritis, en ésta última no existe afectación del lóbulo de la oreja mientras que en la erisipela se afecta todo el pabellón auricular

Tratamiento

Erisipela	ANTIBIÓTICO ELECCIÓN	ALTERNATIVO
Localización miembros inferiores	Penicilina V 500 mg v.o. cada 6h durante ≥ 2 semanas. Amoxicilina/Clavulánico (Augmentine 875/125mg) 1 comprimido v.o. cada 8 horas 10 días	
Formas graves	Penicilina G 1,2 millones de unidades IV cada 6 h, reemplazar por v.o. luego de 36 a 48 horas.	Ceftriaxona 1 g i.v. cada 24h. o Cefazolina 1 a 2 g i.v. cada 8 h.
Sospecha de infecciones estafilocócicas o MRSA o de localización facial.	Vancomicina 1 g i.v. cada 12 h. Dicloxacilina 500 mg v.o. cada 6 h durante 10 días.	Cloxacilina 500mg v.o. cada 6h x 10 días. Nafcilina 500mg v.o. cada 12 h x 7 días
Ante alergia penicilina	Eritromicina 500 mg v.o. cada 6 h durante 10 días	

i.v.: intravenoso; v.o.: vía oral.

OTITIS

Es un proceso infeccioso o inflamatorio del oído.

Otitis externas

Patología infecciosa de la piel del conducto auditivo externo (CAE). Puede ser infeccioso, dermatológico o alérgico.

Clasificación.

- Según forma de inicio: agudas o crónicas.
- Según su extensión: difusas o localizadas.
- Según la zona de origen: primarias o secundarias.
- Según los agentes causantes: bacterianas, fúngicas, virales y mixtas.

Clínica.

Los síntomas más frecuentes son: el dolor, picor, hipoacusia y la sensación de cuerpo extraño en el oído.

Otitis externa difusa

Introducción

Típica De Verano, Por Baño En Mar O Piscinas Con Agua Contaminada Secundario A Traumatismo Por Autolimpieza Con Bastoncillos Higiénicos, Dermatitis Eccematosa. Germen Causal: Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Bacilos Gram Negativos Y Ocasionalmente Hongos.

Diagnóstico

Clínica: Otagia, otorrea, hipoacusia transmisiva. Hacer diagnóstico diferencial con otitis media aguda supurada, si observamos membrana timpánica normal o ligeramente hiperémica confirmamos otitis externa, si membrana timpánica abombado, perforado con otorrea confirmamos que se trata de otitis media aguda supurada, ante la duda diagnóstica o dificultad de visualizar membrana timpánica usar antibiótico sistémicos y gotas locales.

Exploración con otoscopio: Edema variable del CAE, otorrea purulenta. Signo del trago positivo. El CAE se aprecia congestivo, eritematoso, gran intensidad de dolor al tacto, se aprecia una inflamación del CAE en toda su trayectoria con grados variables de estenosis, edema y otorrea que dificulta la visualización del tímpano.

Tratamiento

- Limpieza del CAE: se limpiara con portaalgodones o aspirador, si obstrucción completa del CAE o abundante otorrea avisar a ORL.
- Gotas óticas: Combinación de corticosteroides y antibiotico (Colircusi gentadexa aplicar 3-4 gotas cada 8 horas 7 días o Cetraxal (ciprofloxacino) plus aplicar 3-4 gotas cada 12 horas 7 días u ofloxacino 0,3% gotas 3-5 gotas cada 12h durante 7 días). Otras combinaciones como neomicina, polimixina e hidrocortisona; ciprofloxacino y mometasona; gentamicina y dexametasona.
- Amoxicilina-clavulanico 875/125mg 1 cada 8h durante 7 días o ceftibuteno 400mg c/8h durante 7 días o ciprofloxacino oral 500mg cada 12 horas 7 días. Se debe de añadir antibiótico oral si el paciente esta inmunodeprimido, diabetes mellitus y tiene afectado el CAE con gran edema o celulitis periorbitaria.
- Revisión por ORL preferente dentro de las 48h.
- No mojar el oído, calor seco local.
- Analgésicos y antiinflamatorios vía oral: ibuprofeno 600mg 1 cada 8h durante 3 días.



Otitis externa difusa

Otitis externa localizada o circunscrita

Introducción

Se caracteriza por presencia de un forúnculo en la piel del CAE. Germen causal: Staphylococcus aureus. Tras traumatismo o inmunidad disminuida.

Diagnóstico

Se basa fundamentalmente en una rigurosa historia clínica.

Clínica: Otagia.

Exploración: otoscopia: tumefacción eritematosa circunscrita.

Tratamiento

- Si el absceso no está maduro, no realizar ninguna acción local agresiva.
- Si absceso maduro: Avisar a especialista para drenaje
- Mupirocina en pomada aplicar de forma tópica sobre la lesión 2 veces al día.
- Cloxacilina 500mg cada 8 horas 7 días/ Amoxicilina-Ac. Clavulánico 875/125mg 1 comprimido cada 8 horas 7 días.
- Analgésicos antiinflamatorios.

Otitis externa maligna

Introducción

Es una infección crónica del oído por *Pseudomonas aeruginosa*. Forma grave de otitis externa, que afecta fundamentalmente a la población inmunodeprimida, ancianos o con diabetes mellitus. Puede producir necrosis de partes blandas y osteítis. Agente causal: *Pseudomonas aeruginosa*.

Diagnóstico

- **Clínica:** Otorrea fétida, otalgia lancinante. Es una infección que se caracteriza por una otorrea crónica seropurulenta, verdosa, resistente al tratamiento médico habitual, se acompaña frecuentemente de parálisis facial periférica.
- **Otoscoopia:** Esfacelos y restos necróticos de piel, tejido de granulación o polipoides. Leucocitosis con neutrofilia, VSG y proteína C reactiva elevadas.

Actitud en urgencias.

- Constantes vitales.
- Analítica sanguínea: hemograma, bioquímica básica con PCR y coagulación (si toma de anticoagulantes).
- Cultivo de secreción de oído.
- TAC craneal: oído medio y del hueso mastoides del temporal (se puede observar destrucción ósea del peñasco).
- Interconsulta a ORL de guardia.

Tratamiento

- Tratamiento de elección es ciprofloxacino 500mg 1 cada 12h durante 10 días vía oral asociado con ofloxacino tópico o norfloxacino tópico.

- **¡Importante!** Interconsulta a ORL para valoración del tratamiento intravenoso por importante riesgo de osteomielitis basilar.

Miringitis bullosa u otitis gripal

Introducción

Causa importante de otalgia y a veces de otorrea sero-hemática, de inicio brusco y se produce al inicio de cuadro agudo viral, a la exploración se aprecia una o varias bullas serosas o hemorrágicas que se localizan sobre la membrana timpánica y a veces sobre la piel del conducto auditivo externo óseo, produciendo infección de la piel del CAE y capa externa de tímpano por virus influenzae o parainfluenza.

Diagnóstico

Otalgia intensa en contexto gripal con otorragia u otorrea serosanguinolenta. Otoscopia: Ampollas o bullas serosas, hemorrágicas violáceas sobre la piel del tímpano.

Tratamiento

- Sintomático. A base de gotas óticas que contengan anestésico y corticoides, tener presente la posibilidad de que evolucione a una otitis media aguda en 1 ó 2 días por lo que es recomendable controlar al paciente en 2 ó 3 días.
- Analgésicos vía oral.
- Calor local en periodo agudo.

Otomycosis

Introducción

Infección fúngica de piel de CAE. Agentes causales más habituales son los hongos del género *Aspergillus*, *Cándida*. Predisponentes: traumatismo, tratamientos antibióticos previos.

Diagnóstico

Prurito ótico, otalgia, hipoacusia con sensación de taponamiento ótico. A la Otoscopia se observa masa fúngica que ocupa CAE, puede ser de color marrón-negruzco (*Aspergillus*) o algodonoso (*Candida Albicans*). Secreción pastosa con hifas negruzcas o blanquecinas.

Tratamiento

Si presenta abundante contenido en CAE, avisar a especialista para aspiración y limpieza previa a la aplicación de tratamiento tópico.

Gotas óticas, alternativas:

- Alcohol boricado a saturación aplicar 4 gotas cada 12 horas 7 días
- Menaderm otológico 2-3 gotas cada 8 horas 7 días
- Canesten solución 2-3 gotas cada 8-12 horas

Revisión por ORL.

III. CUERPOS EXTRAÑOS

Introducción

Tres tipos:

- Animales: Insectos
- Vegetales: Semillas
- Inanimados: Tapones de silicona

Diagnóstico

Otoscopia

Tratamiento

- **Extracción.** En el caso de insectos, aplicar en el oído unas gotas de **alcohol o anestésico** antes de la extracción. La mayoría se puede extraer con irrigación de agua templada en una jeringa con cierta presión (EXCEPTO SI EXISTE PERFORACIÓN TIMPÁNICA CONOCIDA).
- **Avisar a ORL:** Si dificultad en la extracción, o duda en la integridad de la membrana timpánica.

BIBLIOGRAFÍA

- Perez Delgado L, Herrera Tolosana S, Fraile Rodrigo JJ. Traumatismos del oído. Heridas. Conmoción laberíntica. Fracturas del hueso temporal. Secuelas. Libro virtual en formación

ORL 22:1-2.

- Basterra Alegría J, Campos Catalá A. Enfermedades del oído externo. Tratado de otorrinolaringología y patología cervicofacial. España: Elsevier; 2009.p.73-81
- Revista Médica Clínica Las Condes. OTALGIA, DOLOR EN EL OÍDO. Vol. 27. Núm. 6. Tema central: Otología. Páginas 892-897 (Noviembre 2016. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-otalgia-dolor-en-el-oido-S0716864016301249>